Instrumento en Terapia Física

Marcha normal

Semana 18

Presente.

Saberes Previos:

¿A qué nos referimos con el término marcha normal?

¿cómo contribuir para tener una marcha normal?

Observa el video

https://youtu.be/Wzh_wD8pMeY

Después de visualizar el video, responde a las siguientes preguntas a través de una herramienta digital

¿Cuáles son los ciclos de la marcha?

¿Cuál es la diferencia entre la fase de apoyo y fase de balanceo?

Logro:

Al finalizar la sesión, el estudiante desarrolla las fases de la marcha normal, elaborando un esquema.

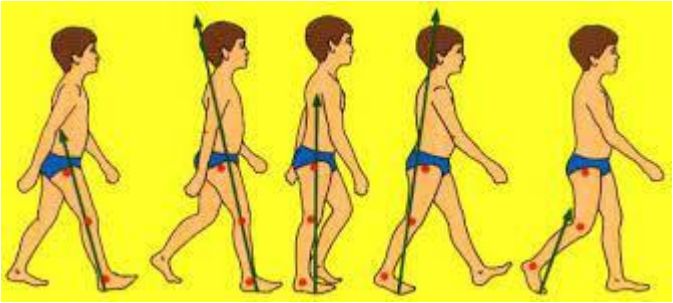
Temario:

Marcha normal

1. Definición
2. Características
3. Fases
4. Evaluación
5. Complicaciones

1.DEFINICIÓN

La locomoción humana normal se ha descrito como una serie de movimientos alternantes, rítmicos, de las extremidades y del tronco que determinan un desplazamiento hacia delante del centro de gravedad.

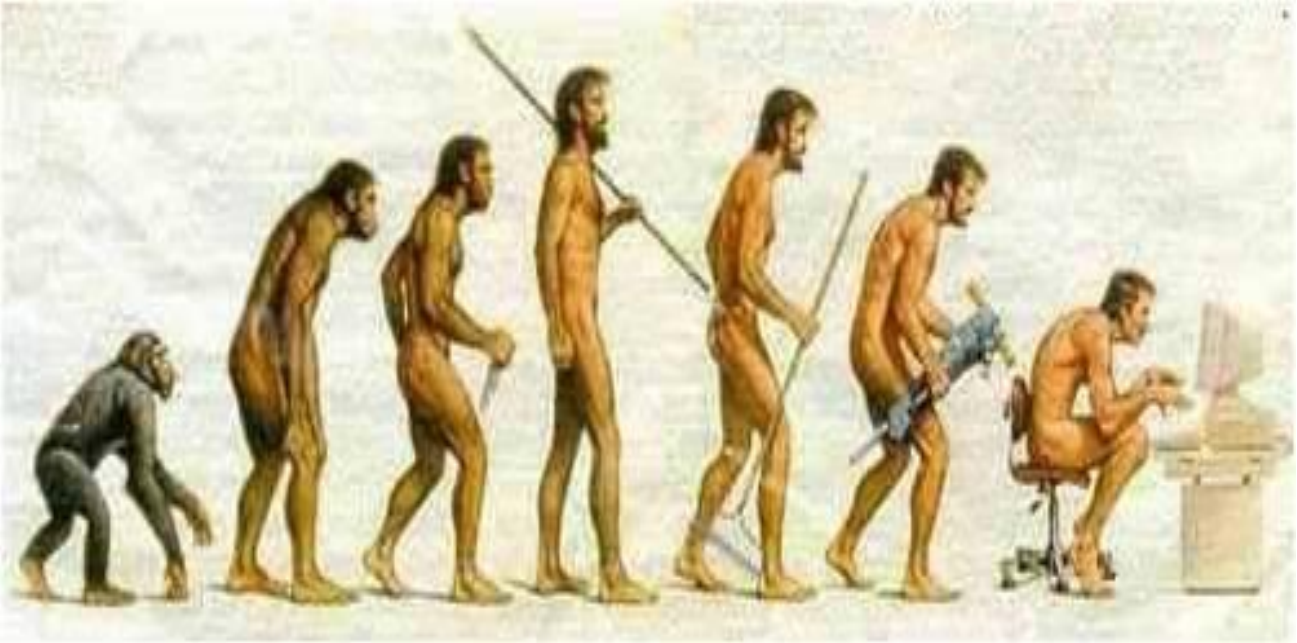


2. CARACTERÍSTICA

La marcha es probablemente la característica más importante del hombre.
Consiste en una serie de movimientos alternantes, rítmicos y repetitivos , de las extremidades y del tronco.
Es comandado por el SNC y determina un desplazamiento automático.

2. CARACTERÍSTICA

Evolución del hombre



3.FASE DE LA MARCHA

Está comprendido entre 2 choques de talón consecutivos del mismo pie y se divide en :

- **FASE DE APOYO :** corresponde al 60% del ciclo y consta de las siguientes etapas:

- Choque de talón
- Apoyo plantar medio
- Apoyo plantar completo
- Apoyo de antepié (impulso hacia adelante).
- Despegue del antepié.

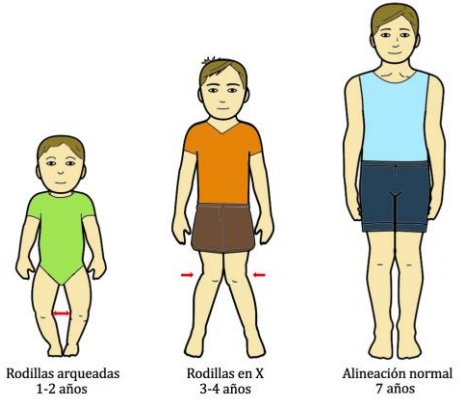
❑ Fase de balanceo u oscilación

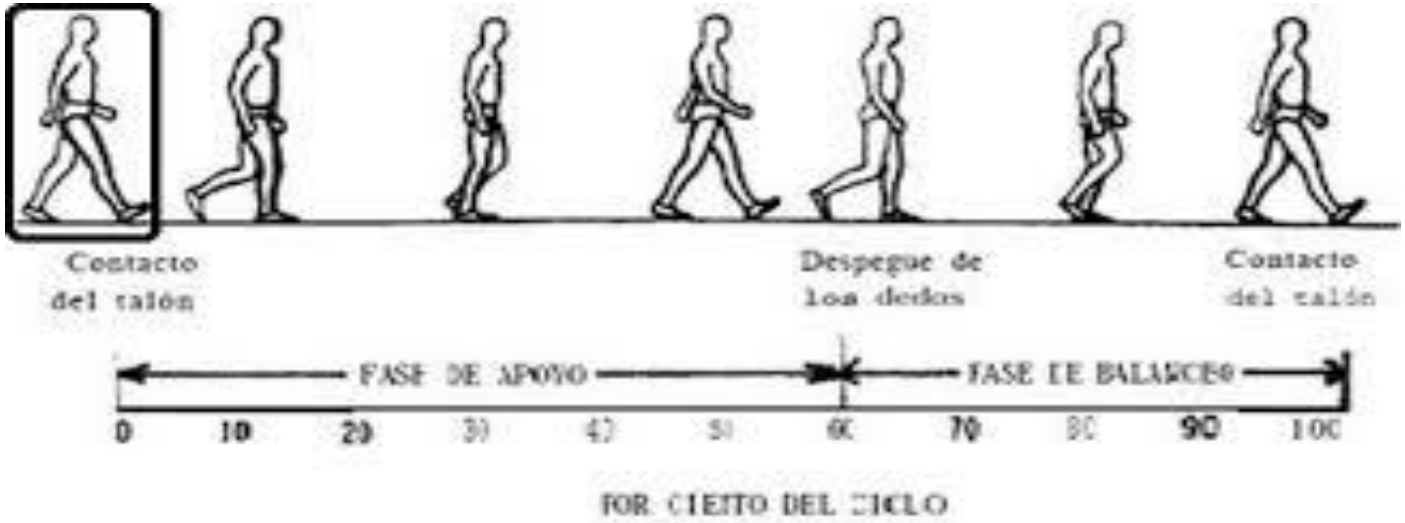
Corresponde al 40% y se inicia desde el despegue del antepié, hasta el contacto con el suelo y consta de las siguientes etapas :

- Periodo de aceleración: flexión de rodilla y oscilación hacia adelante.
- Intervalo de balanceo medio : la pierna oscilante se dirige hacia adelante cruzando la vertical.
- Periodo de desaceleración : frenado y preparación para el siguiente apoyo de talón

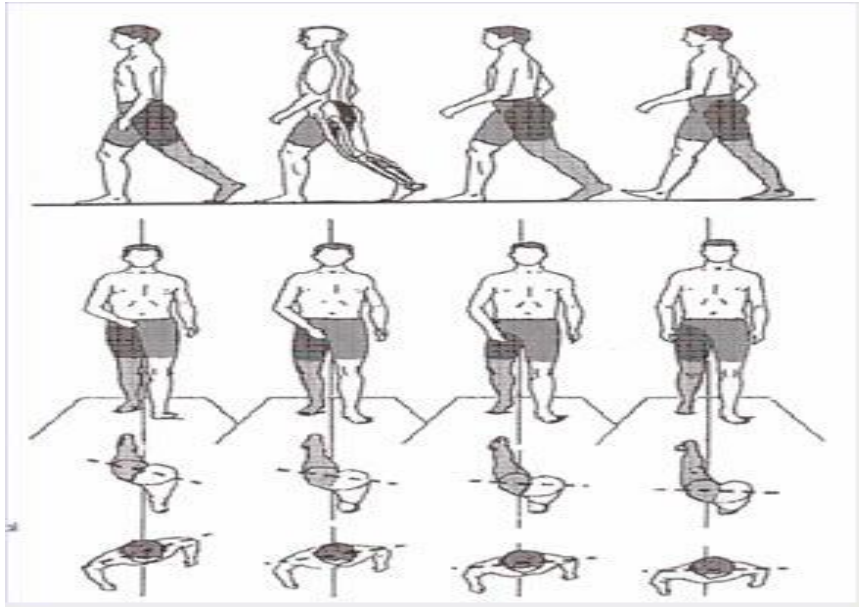
4. EVALUACIÓN

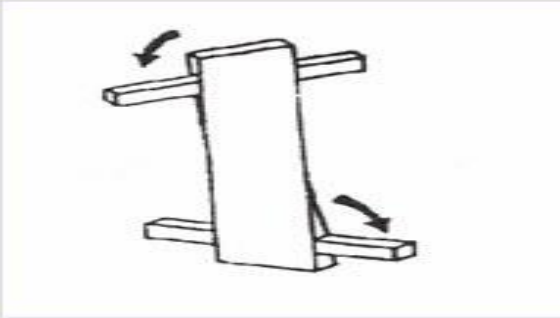
- En la **marcha normal**, el ancho entre las dos líneas queda en una media de 5 a 10 centímetros. Como la pelvis debe desplazarse hacia el lado del apoyo del cuerpo para mantener la estabilidad en el apoyo medio, la estrecha base de sustentación reduce el desplazamiento lateral del centro de gravedad




Contacto del talón
Despegue de los dedos
Contacto del talón
FASE DE APOYO
FASE DE BALANCEO
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
POR CIENTO DEL CICLO

4. EVALUACIÓN





[illegible]

DETERMINANTES DE LA MARCHA

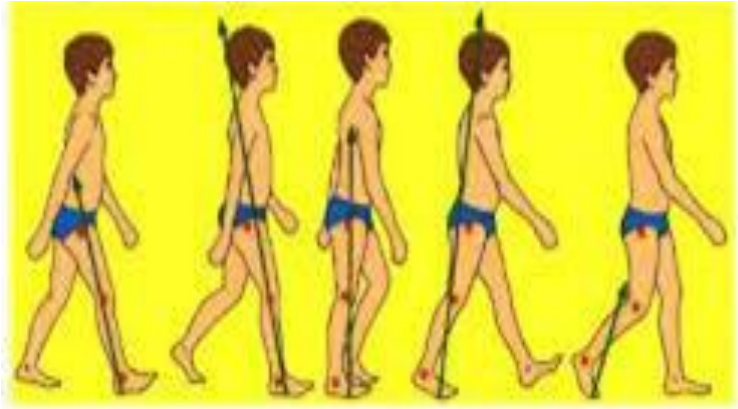
- **Rotación pélvica:** en el plano horizontal, permitiendo el desplazamiento vertical del C.G.C. los brazos se moverán en sentido opuesto para compensar.
- **Giro de la cintura escapular:** en sentido contrario a la cintura pélvica
- **Inclinación pélvica:** durante la marcha la pelvis desciende hacia el lado de la pierna oscilante y la pierna contraria se aduce.
- **Flexión de rodilla:** durante la fase de apoyo ,tras el apoyo de talón, aprox. 15 grados.
- **Base de sustentación:** tiene que ver con la estabilidad y el desplazamiento del C.G.C.

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA MARCHA

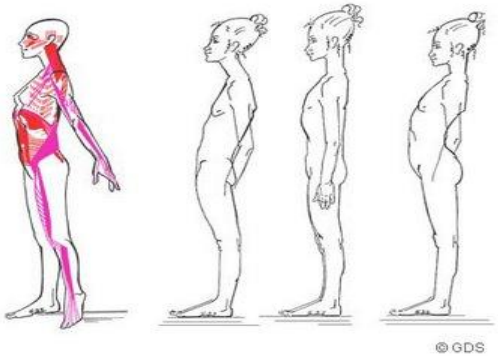
- MARCHA DEL NIÑO.
- MARCHA DEL ANCIANO.
- INFLUENCIA DEL CALZADO.

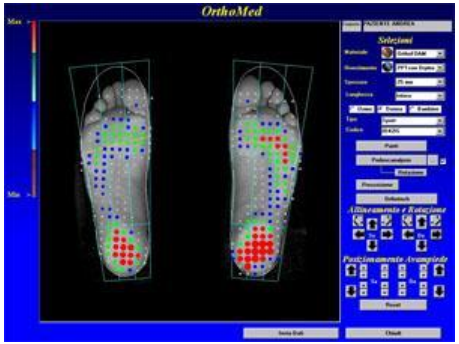
MARCHA DEL NIÑO

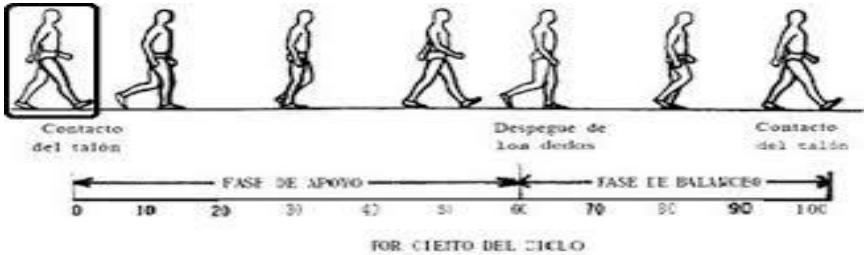
- Menor longitud del paso
- Mayor base de sustentación
- Realiza el apoyo de pie completo
- Escasa flexión de rodilla en fase de apoyo
- Postura en Rot.Ext. De MM II.
- Ausencia de oscilación de MMSS.



4. EVALUACIÓN



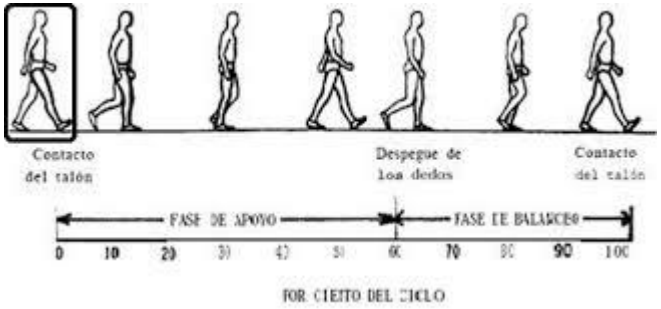


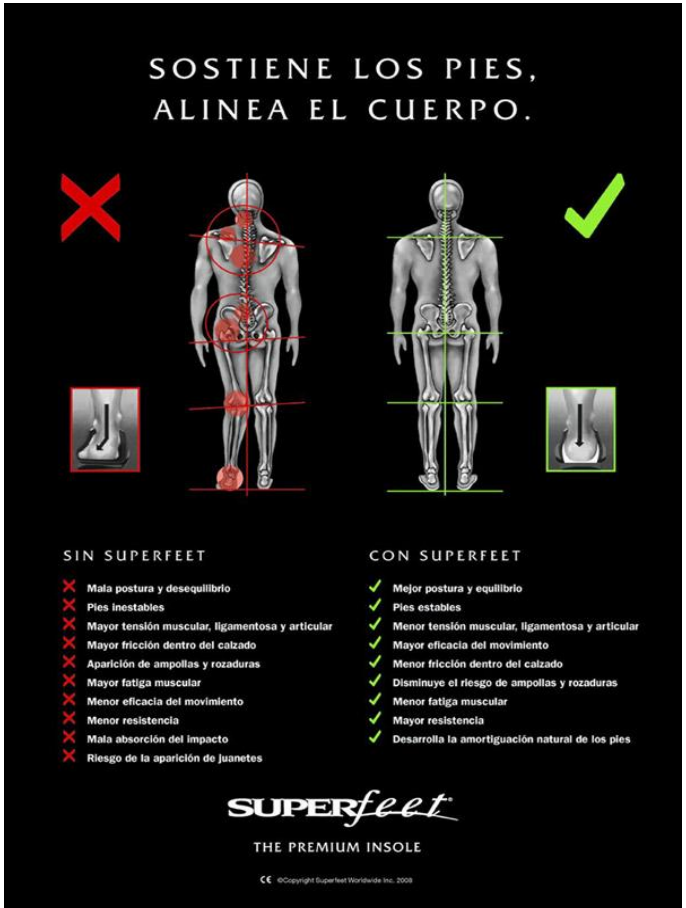


MARCHA DEL ANCIANO

- Disminución de la longitud de paso.
- Aumento de la base de sustentación.
- Alteración de la flex-ext de cadera.
- Reducción de flex. De rodilla en la oscilación
- Reducción de la flexión plantar del tobillo en el despegue.

4. EVALUACIÓN





5. COMPLICACIONES DE LA MARCHA

- Acortamiento de miembro inferior.
- Limitación de amplitud articular.
- Inestabilidad articular.
- Marcha antálgica.
- Marcha patológica por déficit neurológico de origen central.

5. COMPLICACIONES DE LA MARCHA

MARCHA POR DÉFICIT NEUROLÓGICO

M. Hemipléjica: en MI. Se mantiene en ext. Durante todo el ciclo de la marcha.
M. Espástica : MI. En tijeras, con rigidez y mov. Compensatorio de tronco y MMSS.
M. Atáxica : es irregular e inestable, por afectar la sensibilidad profunda produce mov. Incontrolados.
M. Parkinsoniana : adopta un postura en semi -flexión, “marcha del simio”, pasos acelerados persiguiendo su C.G.

Actividad :

Elaboración de un esquema de las fases de la marcha normal.

Actividad N° 6 de la guía de actividades.

Conclusiones

Menciona algunos aportes sobre la fase de la marcha

Aportes

Aportes

Aportes

Metacognición

¿En qué situaciones podré aplicar lo aprendido el día de hoy?

¿Qué estrategia utilicé para aprender el tema?

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Referencias

1. Goic G. A; Chamorro Z. *Semiología médica*. 2a ed. Santiago de Chile: Mediterráneo; 1999.

UBICACIÓN: Biblioteca Av. Arequipa 351. (Sede 7818).

CODIGO: C/616.0754/GOIC

2 Martinez, Carla. Tipos de pie [Internet]. 2022 [citado 1 mayo 2022]. Disponible en: https://www.mundodeportivo.com/uncomo/salud/articulo/tipos-de-pies-51805.html#:~:text=Tipos%20de%20pies-,Tipos%20de%20pies,-Por%20Carla%20Mart%C3%ADnez

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.